Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Benjamín Rodriguez Perez			Sexo	F		M	X
Fecha Nacimiento	20-10-2016	Edad actual	8 años	meses	País natal:		
Domicilio actual:	Av. Hector Huerta. 487.			Teléfono	75349489.		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☐				
Escolaridad actual:	3°	Establecimiento	**Liceo Mixto Los Andes Básico N°1**				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 14-03-25.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Catalina Perez.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 14-03-25.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Marcela Díaz S.	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

DEA.
Dificultad en lectura.- escritura.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Si **(especificar)**

Pediatría: Rinitis crónica.	Psicología: Sí
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) Bajo latido al Sobo

¿Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 2950 | Talla: 47

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Nacio a los 38 semanas
Embarazo de alto riesgo - Hipertenso

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Si~~	No	Especifique motivos y duración: Robos					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~SI~~	No	Vacunas	~~Si~~	No

Observaciones:

Rinitis crónica en Ho

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3m	Se sienta sólo/a: 5m	Camina sin apoyo: 1,2m
Primeras palabras: no recuerda	Primeras frases: no recuerda	Se viste solo/a: 7 o 1.
Controla esfinter vesical Diurno: 3o Nocturno: 3o	Controla esfinter anal Diurno: 3o Nocturno: 3o 1.	

Observaciones:

Existen obtos que los nuestre no recuerdo.

En su actividad motora general se aprecia: ~~S~~ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: ~~S~~ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	~~Si~~	No	Dominancia lateral	Si	~~No~~

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Si~~	No	Prensión	~~Si~~	No	Pinza	~~Si~~	No
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	~~Si~~	No	Escribe	~~Si~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Si~~	No	Comprende prohibiciones	~~Si~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LE

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones:

sin observaciones

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:

No existen más antecedentes

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma					
☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):					

Observaciones:

Sin observaciones.

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Opta por trabajo individual	Sí	~~No~~	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, silabas, etc.)	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados (repetitivos)	Sí	~~No~~
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	~~No~~	Pataletas frecuentes	Sí	~~No~~

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☒ natural ☐ desmesurada

Sonidos: ☒ natural ☐ desmesurada

Personas extrañas: ☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
Es tímido en una primera instancia

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Rinitis crónica en tto. remedios en casa

Alimentación: ☒ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto **Horas que duerme:** 10 horas.

☐ insomnio ☒ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

~~☒ alegre~~ ☒ juguetón/bromista ~~☒ risueño(a)~~ ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:
Se frusta y llora frente a situaciones en que no le dan en el gusto.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Natalia Ponce.	Mamá	25	4 to	Asistente dental.
2. Felipe Walton.	Pareja de mamá	27	4 to	Sin trabajo.
3. Benjamín Rodríguez	hijo	8	3° básico	Estudiante.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
*(Señale aquellos **antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere** el o la estudiante):* Padre en ocasiones consume drogas. Madre sin dificultades.
Observaciones: Sin mayores antecedentes.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	4o).	Asistió a jardín infantil		Sí	No
Nº de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios:					
Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s)	Motivo:	

Situación actual											
Nivel/curso actual	3°-		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No
Asiste regularmente	Sí	No	**Asiste con agrado**	Sí	No	**Apoyo familiar en tareas**	Sí	No	**Amigos (as)**	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☑ Otros familiares ☑ Otros profesionales Pareja de la madre

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

8. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL ESTABLCIMIENTO

Permanencia

*(Señale aquellos **antecedentes en relación a la permanencia** del estudiante en el establecimiento, por ejemplo, se traslada de una ciudad a otra de manera constante, tiene considerado retirarlo del establecimiento antes que termine el año, etc.):*

La madre manifiesta que Benjamín permanecerá todo el año escolar.

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

La madre nos informa que hermano mayor le realiza tocaciones en partes íntimas a Benjamín en visitas a su Padre, quien vive en otro caso, Estuvo en Tto. Sicológico del cual ya está de alta.